

· 指南解读 ·

《中国系统性红斑狼疮诊疗指南(2025 版)》解读

达展云, 陈海烨*

(南通大学附属医院风湿免疫科, 江苏 南通 226001)

[摘要] 系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)是一种临床表现多样、异质性强、治疗方案个体化明显的自身免疫性疾病。2021 年,全球 SLE 发病率为(1.5 ~ 11.0)/10 万人年,欧洲 SLE 发病率为(1.5 ~ 7.4)/10 万人年;2009 年至 2016 年,美国 SLE 发病率高达 49/10 万人年;我国 2013 年至 2017 年,国家医保数据库与国家风湿病数据中心分析,我国的 SLE 发病率为 14.09/10 万人年。不同国家的数据表明 SLE 发病率的地域差异性较大。随着新的诊疗理念和治疗药物不断出现,SLE 的治疗策略取得了显著进展。然而,我国在 SLE 诊治实践中仍面临诊疗不规范、长期管理不足等问题。《中国系统性红斑狼疮诊疗指南(2025 版)》针对临床关注的 12 个问题,依据国内外最新文献研究证据和我国 SLE 诊疗实践,给出了符合我国国情的循证推荐意见,对推动我国 SLE 的标准化诊治进展、改善患者长期预后有着重要作用。《中国系统性红斑狼疮诊疗指南(2025 版)》与《2020 中国系统性红斑狼疮诊疗指南》相比,在治疗目标、激素维持剂量、常见器官受累的处置、生物治疗的治疗地位、新型免疫抑制剂及新型治疗方法等方面都进行了更新。本文重点围绕指南核心推荐的 SLE 治疗目标、病情评估方法、治疗药物(包括糖皮质激素、传统免疫抑制剂、生物制剂)的使用、常见器官受累(包括狼疮肾炎、SLE 合并严重血小板减少症、SLE 合并抗磷脂综合征、神经精神狼疮)的分层治疗方案以及疾病的长期管理等内容进行解读,旨在促进临床医生尽快掌握 SLE 诊疗新进展,推动规范化、个体化诊疗理念在临床实践中的落实,最终提升我国 SLE 患者的整体诊疗水平,改善 SLE 患者的生活质量和长期生存率。

关键词: 系统性红斑狼疮; 指南; 解读

中图分类号: R593.24[†] **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-2870(2025)06-0613-08

DOI: 10.16150/j.1671-2870.2025.06.006

Interpretation of Chinese Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Systemic Lupus Erythematosus (2025 Edition)

DA Zhanyun, CHEN Haiye

Department of Rheumatology and Immunology, Affiliated Hospital of Nantong University, Jiangsu Nantong 226001, China

[Abstract] Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune disease characterized by diverse clinical manifestations, high heterogeneity, and strongly individualized treatment approaches. In 2021, the global incidence of SLE was (1.5 - 11.0)/100 000 person-years, while in Europe, the incidence was (1.5 - 7.4)/100 000 person-years. From 2009 to 2016, the incidence of SLE in the United States reached as high as 49/100 000 person-years. From 2013 to 2017 in China, analysis of the national medical insurance database and the National Rheumatology Data Center showed that the incidence of SLE in China was 14.09/100 000 person-years. Data from different countries indicate significant regional differences in the SLE incidence. With the continuous development of new diagnostic concepts and therapeutic drugs, significant progress has been made in SLE treatment strategies. However, problems such as non-standardized diagnosis and insufficient long-term management remain in the diagnosis and treatment practice of SLE in China. The "Chinese Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Systemic Lupus Erythematosus (2025 Edition)" addresses 12 clinically relevant issues. Based on the latest domestic and international research evidence and China's SLE diagnosis and treatment practice, the guidelines provide evidence-based recommendations tailored to China's national context. These guidelines play a crucial role in promoting the advancement of standardized diagnosis and treatment and in improving the long-term prognosis of SLE patients in China. Compared with the "2020 Chinese Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Systemic Lupus Erythematosus", the "2025 Edition" has been updated in terms of treatment targets,

基金项目: 南通大学附属医院研究型学科发展基金(YJXY202204-XKB03)

※: 现工作于启东人民医院。

通信作者: 达展云 E-mail: dazhanyun@163.com

hormone maintenance doses, management of common organ involvement, therapeutic role of biological therapy, new immunosuppressants, and new treatment methods. This study focuses on interpreting the core recommendations of the guidelines, including SLE treatment targets, disease assessment methods, application of therapeutic drugs (including glucocorticoids, conventional immunosuppressants, and biologics), stratified treatment strategies for common organ involvement (including lupus nephritis, SLE with severe thrombocytopenia, SLE with antiphospholipid syndrome, and neuropsychiatric lupus), and long-term disease management. It aims to help clinicians quickly grasp the latest advances in SLE diagnosis and treatment, promote the implementation of standardized and individualized diagnosis and treatment concepts in clinical practice, and ultimately improve the overall diagnosis and treatment level, quality of life, and long-term survival rate of SLE patients in China.

Key words: Systemic lupus erythematosus; Guidelines; Interpretation

近年来,医学界系统性红斑狼疮(systemic lupus erythematosus, SLE)的重视度提高,2021年的研究报道的SLE全球发病率为(1.5~11.0)/10万人年^[1],其中欧洲登记处数据显示SLE发病率为(1.5~7.4)/10万人年^[2-3];而在2009年至2016年,美国医疗保险人群中分析SLE的发病率为可高达49/10万人年^[4];基于我国2013年至2017年国家医保数据库与国家风湿病数据中心分析,我国的SLE发病率为14.09/10万人年^[5],提示不同国家的数据表明SLE发病率的地域差异性较大。而美国旧金山的数据表明不同人群的SLE发病率差异较大,黑人女性为30.5/10万,亚裔女性为7.2/10万,白人女性为5.3/10万^[6]。国内外相关基础研究和临床研究的不断深入,新的诊疗理念与治疗药物不断涌现,国际诊疗指南也相继更新。

而我国SLE患者的发病、临床表现、主要临床转归等与欧美国家不完全相同,我国SLE患者与欧洲地区患者相比,出现肾脏受累(47.4%比27.9%)、血液系统受累(56.1%比18.2%)的比例更高,而神经系统受累(4.8%比19.4%)的比例更低^[7],国际SLE诊疗指南推荐意见未必符合中国的诊疗实践。随着新的诊治研究结果与新型治疗药物不断出现,我国《2020中国系统性红斑狼疮诊疗指南》^[8](以下简称2020版指南)已不能很好地满足指导当下SLE诊疗实践的需求。在此背景下,2025年6月《中华医学杂志》发布了中华医学会风湿病学分会组织相关领域专家制定的《中国系统性红斑狼疮诊疗指南(2025版)》^[9](以下简称为2025版指南)。2025版指南在2020版指南的基础上进行了全面更新,结合国内外最新研究进展和临床实践需求,提出了多项创新性内容,推进我国SLE临床决策的科学性和规范性,从而达到改善该病疾病预后的目的。本文就2025版指南更新推荐的SLE治疗目标、病情评估方法、治疗药物的使用、常见器官受累的分层治疗方案以及疾病的长期管理等问题作解读。

1 治疗新目标及病情评估方法

1.1 明确治疗新目标

SLE诊断具有复杂性,我国SLE患者的平均诊断延误时间为10.8个月^[10],且有易复发的特征,可导致器官损害加重和预后不良。早期诊断、及时干预在SLE的诊疗过程中尤为重要。2025版指南推荐使用2012年国际狼疮研究临床协作组(Systemic Lupus International Collaborating Clinics, SLICC)或2019年欧洲抗风湿病联盟/美国风湿病学会(European League Against Rheumatism/American College of Rheumatology, EULAR/ACR)制定的SLE分类标准进行诊断,同时明确指出SLE的治疗原则是早期干预、达标治疗。2025版指南明确,SLE的治疗目标为,通过达标治疗策略在短期治疗中控制患者的疾病活动,尽快达到临床缓解,或至少达到低疾病活动度状态(low lupus disease activity state, LLDAS),并通过长期治疗维持病情持续缓解,预防和减少复发,减少药物不良反应,预防和减少器官损害,提高患者生活质量,最终降低病死率。

1.2 更新评估新方法

2025版指南首次提出中国患者达标治疗的目标为2021年SLE临床缓解和低疾病活动度定义工作组^[11]提出的临床缓解标准;若难以达到临床缓解,可使用亚太狼疮协作组^[12]推荐的SLE的LLDAS为替代目标(见表1),进行病情评估并及时调整治疗方案。

2025版指南认为SLE疾病活动评分(SLE-disease activity score, SLE-DAS)有助于解决SLE疾病活动指数(SLE disease activity index, SLEDAI)-2000在评估疾病活动变化灵敏度上的不足;与SLEDAI-2000相比,在验证队列中的SLE-DAS在显示疾病改善(89.5%比47.4%, $P=0.008$)和恶化(95.5%比59.1%, $P=0.008$)方面,SLE-DAS的灵敏度更佳,预

表 1 SLE 临床缓解和低疾病活动度定义

Table 1 Definitions of clinical remission and low disease activity of SLE

项目	治疗目标	
	临床缓解	低疾病活动度
SLE 疾病活动指数 (SLEDAI-2000)	0 分	≤4 分
医师整体评估	≤0.5 分	≤1 分
治疗方案	抗疟药(羟氯喹等)、低剂量糖皮质激素(泼尼松≤5 mg/d)和(或)稳定剂量的免疫抑制剂,包括生物制剂 7.5 mg/d),和(或)稳定剂量的免疫抑制剂/生物制剂	

测损伤累积的能力更强^[13]。同时,明确 SLE 国际合作组损伤指数 (SLICC damage index, SDI) 是唯一国际公认、已得到验证的 SLE 器官损害评估标准,可用于更好地判断 SLE 患者的预后。

1.3 达标治疗重要性

达标治疗在 SLE 的治疗中具有可行性。一项系统综述指出,与未达到 LLDAS 或缓解状态的患者相比,SDI 增加的比值比分别是 LLDAS 患者的 0.19 ~ 0.88、缓解患者的 0.49 ~ 0.75,表明缓解状态或 LLDAS 可降低器官损害、疾病复发及其他不良结局的概率^[14]。维持疾病持续缓解或处于 LLDAS 超过 3~6 个月,将有助于减少复发及脏器损害,特别是 LLDAS 时间≥50% 的 SLE 患者,复发风险显著降低,预后显著改善^[15-17]。在临床实践中,定期对 SLE 患者进行疾病活动度评估,及时调整治疗方案,有利于 SLE 患者的达标治疗,从而改善预后。

2 治疗策略的新手段

2.1 糖皮质激素(以下简称激素)

激素在治疗 SLE 中发挥着至关重要的作用,是 SLE 诱导缓解治疗中最常用,且国内外指南一致推荐的控制 SLE 病情的基础药物。与 2020 版指南相比,2025 版指南推荐的临床激素使用时机以及基础方案未发生变化,仍应根据疾病活动度、受累器官的类型及其受累严重程度制定个体化的激素治疗方案,对轻、中、重不同活动度的 SLE 患者可分别使用 ≤10 mg/d、0.5~1.0 mg·kg⁻¹·d⁻¹、≥1 mg·kg⁻¹·d⁻¹ 泼尼松或等效剂量的其他激素治疗。其中对合并狼疮危象的 SLE 患者,在推荐使用激素冲击(静脉滴注甲泼尼龙 250~1 000 mg/d,通常连续使用 3 d 为 1 个疗程)中较 2020 版指南进一步降低了激素冲击治疗的最低有效剂量,有助于进一步减少激素的不良反应。

对病情长期稳定的 SLE 患者,各国 SLE 指南、共识推荐的激素减量阈值趋于严格化。2025 版指南根据真实世界的前瞻性研究提出激素维持剂量

进一步降低,应减至 5 mg/d 泼尼松或相当剂量的其他激素,并在可能的情况下尝试停药。相较于泼尼松剂量从未减至 <5 mg/d 的 SLE 患者,泼尼松维持剂量 <5 mg/d 的 SLE 患者器官损伤风险随时间明显降低 (IRR=0.96, P=0.007),且并未增加 SLE 复发的风险^[18]。总之,在 SLE 的治疗中,糖皮质激素应使用最小有效剂量,既控制了治疗病情,又降低了激素的不良反应。

2.2 羟氯喹

在 SLE 治疗中,2025 版指南继续推荐使用羟氯喹作为基础治疗,指出中国 SLE 患者使用羟氯喹的推荐剂量为 5 mg·kg⁻¹·d⁻¹,且不超过 400 mg/d,具体剂量可根据患者复发风险和视网膜毒性风险进行个体化调整。强调在服药前及服药期间均需关注羟氯喹相关视网膜病变,其高风险因素包括长期服用和(或)使用高剂量(>5 mg·kg⁻¹·d⁻¹)羟氯喹、伴有肝肾功能不全、合并使用他莫昔芬、视网膜或黄斑疾病史、年龄超过 45 岁等。同时指出,羟氯喹的禁忌证包括对羟氯喹或其类似物过敏,既往因类似药引发的视网膜病变,也可能与 QT 间期延长及心脏传导阻滞发生相关,因此存在基础相关心脏疾病的患者,或在合并使用特定药物时,需警惕发生心律失常的风险。但对于长期使用羟氯喹和心肌病变之间的因果关系及具体风险因素,仍需进一步探讨及证实。

2.3 免疫抑制剂

免疫抑制剂的使用可降低激素的累积量,预防疾病复发。与 2020 版指南相比,2025 版指南推荐的免疫抑制剂使用时机未改变,依旧建议对激素联合羟氯喹治疗效果不佳或无法将激素减至维持剂量者联合使用传统免疫抑制剂治疗。对伴有脏器受累者,建议初始治疗时即加用传统免疫抑制剂,其更新对激素维持剂量提出明确范围为 ≤5 mg/d 泼尼松或等效剂量的其他激素。

同时,2025 版指南明确推荐,在 SLE 患者合并活动性皮肤病变对于局部治疗(激素或他克莫司软膏)及羟氯喹疗效不佳时,可加用口服激素联合免

疫抑制剂治疗,甲氨蝶呤和霉酚酸酯(mycophenolate mofetil, MMF)疗效相当,沙利度胺和来那度胺可用于其他药物应答不佳的患者。

此外,2025版指南新推荐,在经其他传统免疫抑制剂治疗应答不佳的活动性SLE患者中,可使用西罗莫司(又称雷帕霉素)治疗,有助于显著降低SLEDAI-2000评分,减少泼尼松用量,改善血清学指标补体及抗dsDNA抗体^[19]。西罗莫司可改善疾病活动度,并有助于激素减量,其疗效与他克莫司相当。对于西罗莫司在狼疮肾炎(lupus nephritis, LN)的维持治疗、SLE相关难治性血小板减少和合并抗磷脂综合征(antiphospholipid syndrome, APS)等中的治疗效果研究较少,仍需要进一步探讨。

2.4 生物制剂

与2020版指南相比,2025版指南中生物制剂治疗SLE的推荐强度提升为强推荐,适用人群包括中重度SLE一线选择,轻度二线治疗(与免疫抑制剂为同等推荐级别),同时治疗SLE的推荐药物选择也更多,包括B细胞为主要靶点的药物(如贝利尤单抗、泰它西普、利妥昔单抗和奥妥珠单抗),以及I型干扰素受体拮抗剂阿尼鲁单抗和C₅补体抑制剂依库珠单抗等。随着生物制剂在SLE治疗中的地位提升以及使用率的增加,越来越多的SLE患者可以将激素减至维持剂量(≤ 5 mg/d泼尼松或等效剂量的其他激素)甚至0激素。

贝利尤单抗是全球首个获批用于治疗SLE的生物制剂,其可显著增加SLE反应指数4(SLE responder index 4, SRI-4)应答率、减少SLE疾病活动度和严重复发,同时可改善包括肾脏、皮肤、关节等在内的多种SLE临床表现,并减少激素用量。2023年EULAR也推荐,对羟氯喹(单药或联合激素)无应答或不能将激素减至维持剂量的SLE患者或活动性增殖性LN患者,可联合贝利尤单抗治疗^[20]。泰它西普已获得我国国家药品监督管理局批准,用于SLE治疗,可显著提高SRI-4应答率、改善SLE疾病活动度和LN蛋白尿水平,有助于激素及免疫抑制剂减量。

利妥昔单抗目前虽在治疗中重度SLE及治疗LN的试验中均未达到终点,但有案例表明其治疗部分重症难治性SLE患者有效^[21]。同时,我国2021年LN诊疗规范也推荐,利妥昔单抗可用于对激素联合MMF或环磷酰胺(cyclophosphamide, CTX)疗效不佳的增生性LN患者^[22]。2023 EULAR^[20]推荐将利妥昔单抗用于治疗难治性LN,也可用于治疗严

重自身免疫性血小板减少。此外,利妥昔单抗可用于神经精神狼疮(neuropsychiatric SLE, NPSLE)的治疗。奥妥珠单抗与利妥昔单抗相比有更强的B细胞杀伤作用,临床试验表明奥妥珠单抗可用于治疗活动性LN,提高肾脏缓解率与持续性肾脏反应,其中高活动度(尿总蛋白肌酐比值 ≥ 3 g/g,低补体,高滴度抗dsDNA抗体,IV型LN,合并V型LN)的患者使用奥妥珠单抗的获益更高^[23]。奥妥珠单抗也可用于对利妥昔单抗继发性无反应的LN和无肾脏受累的患者,并可降低疾病活动度^[24]。

阿尼鲁单抗已被美国食品药品监督管理局批准用于治疗中重度SLE,可提高SRI-4应答率,提高活动性III/IV型LN患者的完全肾脏反应,减少激素用量及复发率。2023 EULAR^[20]推荐,对羟氯喹(单药或联合激素)无应答的SLE患者或不能将激素减至维持剂量的SLE患者,可考虑联合阿尼鲁单抗治疗。但阿尼鲁单抗尚未通过我国国家药品监督管理局批准,其在我国人群中的疗效尚未明确仍需进一步探讨。目前关于依库珠单抗治疗SLE的研究较少,其临床疗效价值仍需进一步探讨。

2.5 创新疗法

2025版指南推荐,对于重度或难治性SLE患者,可考虑使用血浆置换或免疫吸附作为一线治疗的辅助措施;对于难治性或合并感染的SLE患者,可考虑在原治疗基础上加用静脉注射用免疫球蛋白改善结局。有系统分析表明,在常规治疗基础上加用雷公藤制剂可有助于降低狼疮活动性和提高总体缓解率^[25]。

2025版指南新增推荐,在SLE患者特别是对传统疗法反应不佳的患者中使用Janus激酶抑制剂。研究表明,其在治疗SLE相关肌肉骨骼和皮肤黏膜损害方面具有较好的疗效,目前已有巴瑞替尼、托法替布被用于临床。此外,新型Janus激酶抑制剂如德克伐替尼、菲戈替尼等有望未来在临床中应用。2025版指南新提出,自体嵌合抗原受体T细胞疗法可用于难治性SLE,可降低疾病活动度,促进常规治疗药物减停,但由于其制备工艺复杂、治疗成本高昂,其治疗SLE的长期疗效、安全性及最佳治疗方案仍待高质量的临床研究证实。

3 SLE器官受累处理新策略

相比于2020版指南,2025版指南对SLE相关器官受累更为重视,不仅单独列出了SLE器官和系

统受累的处理方式,共给出 8 条推荐意见,并汇总了研究证据。

3.1 LN

LN 治疗的前提是早期识别肾脏受累和行诊断性肾脏穿刺检查。相比于 2020 版指南,2025 版指南指出,LN 的治疗方案的基础是肾脏病理类型及肾脏病变活动性。2025 版指南推荐使用 2003 年国际肾脏病学会/肾脏病学会工作组的建议^[26],及 2018 年国际肾脏病学会/肾脏病学会工作组对 LN 病理分型和美国国立卫生研究院推荐的 LN 活动性/慢性指数评分修订版^[27],根据肾小球病理将 LN 分为六型(I 型轻微系膜 LN、II 型系膜增殖性 LN、III 型局灶性 LN、IV 型弥漫性 LN、V 型膜性 LN 和 VI 型晚期硬化性 LN),同时进一步根据是否存在重大的血管和肾小管间质病变以及活动性/慢性指数评分对不同病理分型进行具体分级。

2025 版指南极为重视肾脏病变活动性对治疗方案的影响。对于 I 型与 II 型 LN 伴非肾源性蛋白尿者,建议根据肾外表现进行治疗。对于 II 型 LN 伴肾源性蛋白尿者,建议使用激素和(或)传统免疫抑制剂进行治疗。对于活动性 III 型/IV 型,伴或不伴 V 型 LN 患者新推荐了 3 种诱导治疗一线方案:①激素联合 MMF 或静脉注射 CTX,可联合贝利尤单抗进行治疗;②激素联合钙调磷酸酶抑制剂(calcineurin inhibitors,CNI);③激素联合 MMF 和 CNI。对单纯 V 型 LN,推荐根据尿蛋白水平制定治疗方案:①尿蛋白<1 g/24 h 者,通常预后良好,建议根据肾外表现进行治疗;②尿蛋白 1.0~3.5 g/24 h 者,建议使用激素联合传统免疫抑制剂治疗;③尿蛋白>3.5 g/24 h 者,建议优选激素联合 MMF+CNI 方案,维持期建议使用 MMF、CNI、CNI+MMF、硫唑嘌呤或雷公藤多苷制剂。2025 版指南推荐的“多靶点”治疗(包括固定剂量他克莫司、减量 MMF 和激素)尤其适用于广泛足细胞损伤导致大量蛋白尿的 LN 患者,可显著提高肾脏反应,而其不良反应发生率与传统静脉注射 CTX 方案差异无统计学意义。而对于活动性 III 型/IV 型,伴或不伴 V 型 LN 患者的诱导治疗,以及初始治疗效果不佳或反复复发的 LN 患者,在激素和免疫抑制剂的基础上可联合生物制剂治疗;贝利尤单抗联合标准治疗(MMF 或 CTX 序贯硫唑嘌呤)可以显著提高肾脏反应;而利妥昔单抗可显著提高 LN 患者的完全肾脏缓解率,改善疾病活动度。

此外,2025 版指南提出,对于 LN 患者,除了优化免疫抑制治疗外,还应加强对导致 LN 进展的非免

疫驱动因素的管理,包括低盐饮食(盐摄入量<5 g/d)、避免高蛋白摄入、戒烟和适度运动、减重(体质指数 ≤ 25 kg/m²)、首选肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂控制血压达标[<120/70 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)],减少蛋白尿、延缓 CKD 进展等。

3.2 SLE 合并严重血小板减少症

免疫相关血小板减少症(immune thrombocytopenia, ITP)是 SLE 血液系统受累的常见表现之一,其严重程度分级需结合血小板计数及出血症状进行评分。2025 版指南指出,SLE 合并 ITP 的治疗目标是维持安全水平的血小板计数以防止发生出血事件,而非使血小板计数恢复正常,特别是 SLE 合并严重 ITP 的治疗目标为减少出血事件。

目前 SLE 合并 ITP 的治疗仍主要参考原发性 ITP 的诊治指南。对于急性期治疗可考虑使用大剂量激素(包括甲泼尼龙冲击)或静脉注射人免疫球蛋白;经上述治疗效果不佳者,可使用激素联合利妥昔单抗或传统免疫抑制剂治疗。其中,2025 版指南推荐可将利妥昔单抗提前至与传统免疫抑制剂同一时机使用,且其推荐等级较 2020 版指南显著增加。另也有研究表明,贝利尤单抗可显著提高 SLE 合并 ITP 患者的血小板计数和缓解率,总体缓解率为 90%,完全缓解率为 70% ($P<0.05$)^[28]。此外,可将促血小板生成药物用于危及生命的出血事件或急症手术时的紧急治疗。

3.3 SLE 合并 APS

APS 特征是血栓形成和与抗磷脂抗体(antiphospholipid antibodies, APLs)相关的产科并发症。APLs 阳性会显著增加 SLE 患者发生血小板减少、瓣膜病变损害、动脉粥样硬化心血管疾病等疾病的风险。2020 版指南并未关注到 SLE 合并 APS 的诊治方案。对于 SLE 合并 APS 患者,2025 版指南中新推荐建议参照 2023 年 ACR/EULAR 制定的 APS 分类标准进行诊断^[29]。同时新增 SLE 合并 APS 的分层治疗推荐,合并血栓性 APS 者,在首次出现动脉或者无诱因静脉血栓事件后,建议接受长期口服维生素 K 拮抗剂抗凝治疗;APLs 持续阳性但无血栓事件者,可考虑口服低剂量阿司匹林(75~100 mg/d)进行一级预防治疗;APLs 持续阳性的妊娠患者,则推荐根据既往有无病理妊娠史、血栓史及 APLs 抗体类型情况使用低剂量阿司匹林和(或)低分子肝素治疗(见表 2),有助于推进我国 SLE 的临床规范化治疗。

表2 SLE合并APLs阳性的治疗推荐

Table 2 Treatment recommendations for SLE combined with APLs positive

治疗方案	治疗推荐
血栓事件治疗方案	
APLs阳性、无相关症状的SLE患者	阿司匹林(75~100 mg/d)一级预防
无诱因的首次静脉血栓事件者	长期抗凝治疗,口服维生素K拮抗剂,INR目标值为2.0~3.0
确诊APS者首次出现动脉血栓事件	口服维生素K拮抗剂优于单用阿司匹林,根据个体出血与血栓复发风险设定INR目标值为2.0~3.0或3.0~4.0;亦可考虑华法林标准抗凝联合阿司匹林治疗
3种抗磷脂抗体阳性且出现血栓事件者	不推荐应用利伐沙班
病理妊娠治疗方案	
APLs持续阳性、无既往血栓事件及病理妊娠史的SLE患者	阿司匹林(75~100 mg/d)
APLs持续阳性合并既往血栓事件的SLE患者	阿司匹林(75~100 mg/d)联合治疗剂量低分子肝素
APLs阳性合并符合APS分类标准的妊早期反复流产的SLE患者	阿司匹林(75~100 mg/d)联合预防剂量低分子肝素
APLs阳性合并符合APS分类标准的晚期流产、胎盘功能不全相关病理妊娠的SLE患者	阿司匹林(75~100 mg/d)联合治疗剂量低分子肝素

3.4 NPSLE

NPSLE临床表现复杂多样,无特异的实验室指标,且缺乏统一的诊断标准。2020版指南仅对重度NPSLE建议先用激素冲击治疗,效果不佳时加用环磷酰胺。2025版指南则建议,活动性NPSLE可使用激素联合免疫抑制剂治疗,同时新增NPSLE合并抗磷脂抗体阳性及脑血管病变的治疗时需考虑联合抗血小板和(或)抗凝治疗。NPSLE的治疗方案包括激素联合免疫抑制剂、抗血小板/抗凝治疗以及对症治疗,也可采用鞘内注射地塞米松和甲氨蝶呤治疗。2025版指南新推荐的治疗方案有助于提高NPSLE患者生存率和无疾病复发率,改善预后。

2025版指南指出,生物制剂也对NPSLE的治疗有效,可用于难治性NPSLE、具有头痛症状的轻症NPSLE患者的治疗。同时对具有精神症状的患者可使用抗焦虑、抑郁以及心理干预等治疗措施;对于NPSLE患者应预防及鉴别神经系统感染,关注血压管理及代谢因素。

4 SLE患者长期管理新观点

4.1 健康教育

SLE患者疾病的活动可能与环境或其他外源性刺激有关。健康管理对于SLE患者的长期治疗以及改善生活质量至关重要。2025版指南精炼地介绍了患者健康管理的相关内容,包括适度运动、接受必要的社会心理干预、避免接触常见的危险物质、防晒、戒烟、补充维生素D等方法,有助于降低

疾病活动度及减少疾病复发。

4.2 围妊娠期管理

随着SLE患者生存率和生活质量的提高,育龄期的女性对生育的需求正在不断增加。但SLE病情活动会增加妊娠失败、母婴病死等风险,是育龄期SLE女性患者和临床医师必须面对的重大问题,因此围妊娠期管理就显得尤为重要。2025版指南新明确指出SLE育龄期女性只有在病情稳定≥6个月、口服泼尼松≤15 mg/d(或等效剂量的不含氟类激素)、停用可能致畸药物至所需时间、24 h尿蛋白定量≤0.5 g/d且无重要脏器损害的前提下,方可考虑妊娠;强调围妊娠期管理的重要性,患者需要在孕前多学科评估、孕期严格监控疾病活动度及胎儿生长发育情况、产后6~12个月内密切随访和控制疾病活动度。此外,依旧强调羟氯喹在围妊娠期管理中的关键治疗作用。总的来说,SLE患者在符合前述条件下可以考虑妊娠,但其妊娠期疾病复发以及发生不良妊娠的风险仍高于普通人群,需要与患者及家属充分沟通,谨慎考虑。

4.3 感染及预防

目前感染仍是我国SLE患者死亡的首要病因,及时评估SLE患者的感染风险,及时预防、识别、控制感染对长期管理尤为重要。2025版指南推荐,SLE患者可通过接种疫苗预防感染,同时对疫苗接种的类型、时机做出了明确推荐。建议患者可在医师具体评估当前SLE疾病活动度、当前激素应用剂量、是否应用免疫抑制剂以及生物制剂,特别是B细胞清除治疗,以及明确自身意愿后适时接种流感病毒、肺炎链球菌、乙型肝炎、人乳头瘤状病毒、带

带状疱疹病毒等灭活疫苗,以减少感染的发生,降低死亡风险。

5 总结和展望

《中国系统性红斑狼疮诊疗指南(2025 版)》是一部融合国际先进理念与我国实际国情且可操作性强、切实可行的临床实践指南,对于 SLE 的临床诊治发挥重要指导作用,临床医师应加强对 2025 版指南的学习和理解,达到推进 SLE 患者的规范诊治、改善长期预后。

利益冲突说明/Conflict of Interests

所有作者声明不存在利益冲突。

伦理批准及知情同意/Ethics Approval and Patient Consent

本文不涉及伦理批准及知情同意。

作者贡献/Authors' Contributions

达展云负责选题设计、论文撰写审校,陈海烨负责文献查阅、资料收集。

[参考文献]

- [1] BARBER M R W, DRENKARD C, FALASINNU T, et al. Global epidemiology of systemic lupus erythematosus[J]. Nat Rev Rheumatol, 2021, 17(9): 515-532.
- [2] MAGRO R, BORG A A. Characterisation of patients with systemic lupus erythematosus in Malta: A population based cohort cross-sectional study[J]. Biomed Res Int, 2018, 2018: 2385386.
- [3] GERGIANAKI I, FANOIRIAKIS A, REPA A, et al. Epidemiology and burden of systemic lupus erythematosus in a Southern European population: data from the community-based lupus registry of Crete, Greece[J]. Ann Rheum Dis, 2017, 76(12): 1992-2000.
- [4] LI S, GONG T, PENG Y, et al. Prevalence and incidence of systemic lupus erythematosus and associated outcomes in the 2009-2016 US Medicare population[J]. Lupus, 2020, 29(1): 15-26.
- [5] LI M, LI C, CAO M, et al. Incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus in urban China, 2013-2017: A nationwide population-based study[J]. Sci Bull (Beijing), 2024, 69(19): 3089-3097.
- [6] DALL'ERA M, CISTERNAS M G, SNIPES K, et al. The incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus in San Francisco County, California: The California Lupus Surveillance Project[J]. Arthritis Rheumatol, 2017, 69(10): 1996-2005.
- [7] LI M, ZHANG W, LENG X, et al. Chinese SLE Treatment and Research group (CSTAR) registry: I. Major clinical characteristics of Chinese patients with systemic lupus erythematosus[J]. Lupus, 2013, 22(11): 1192-1199.
- [8] 中华医学会风湿病学分会, 国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心, 中国系统性红斑狼疮研究协作组. 2020 中国系统性红斑狼疮诊疗指南[J]. 中华内科杂志, 2020, 59(3): 172-185.
Chinese Rheumatology Association, National Clinical Research Center for Dermatologic and Immunologic Diseases, Chinese Systemic Lupus Erythematosus Treatment and Research Group. 2020 Chinese guidelines for the diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus[J]. Chin J Intern Med, 2020, 59(3): 172-185.
- [9] 国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心, 中国系统性红斑狼疮研究协作组, 中华医学会风湿病学分会. 中国系统性红斑狼疮诊疗指南(2025 版)[J]. 中华医学杂志, 2025, 105(23): 1879-1906.
National Clinical Research Center for Dermatologic and Immunologic Diseases, Chinese Systemic Lupus Erythematosus Treatment and Research Group, Chinese Rheumatology Association. Chinese guidelines for the diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus (2025 edition)[J]. Natl Med J China, 2025, 105(23): 1879-1906.
- [10] LI M, WANG Y, ZHAO J, et al. Chinese SLE Treatment and Research Group (CSTAR) registry 2009-2019: major clinical characteristics of Chinese patients with systemic lupus erythematosus[J]. Rheumatol Immunol Res, 2021, 2(1): 43-47.
- [11] VAN VOLLENHOVEN R F, BERTSIAS G, DORIA A, et al. 2021 DORIS definition of remission in SLE: final recommendations from an international task force[J]. Lupus Sci Med, 2021, 8(1): e000538.
- [12] FRANKLYN K, LAU C S, NAVARRA S V, et al. Definition and initial validation of a lupus low disease activity state (LLDAS)[J]. Ann Rheum Dis, 2016, 75(9): 1615-1621.
- [13] JESUS D, MATOS A, HENRIQUES C, et al. Derivation and validation of the SLE Disease Activity Score (SLE-DAS): a new SLE continuous measure with high sensitivity for changes in disease activity[J]. Ann Rheum Dis, 2019, 78(3): 365-371.
- [14] KOSTOPOULOU M, MUKHTYAR C B, BERTSIAS G, et al. Management of systemic lupus erythematosus: a systematic literature review informing the 2023 update of the EULAR recommendations[J]. Ann Rheum Dis, 2024, 83(11): 1489-1501.
- [15] PITSIGAVDAKI S, NIKOLOUDAKI M, GARANTZIOTIS P, et al. Pragmatic targets for moderate/severe SLE and their implications for clinical care and trial design: sustained

- DORIS or LLDAS for at least 6 months is sufficient while their attainment for at least 24 months ensures high specificity for damage-free progression[J]. *Ann Rheum Dis*, 2024,83(4):464-474.
- [16] GOLDER V, KANDANE-RATHNAYAKE R, LI N, et al. Association of sustained lupus low disease activity state with improved outcomes in systemic lupus erythematosus: a multinational prospective cohort study[J]. *Lancet Rheumatol*, 2024,6(8):e528-e536.
- [17] GOLDER V, KANDANE-RATHNAYAKE R, HUQ M, et al. Lupus low disease activity state as a treatment endpoint for systemic lupus erythematosus: a prospective validation study[J]. *Lancet Rheumatol*, 2019,1(2):e95-e102.
- [18] FLORIS A, CHESSA E, SEBASTIANI G D, et al. Glucocorticoid tapering and associated outcome in patients with newly diagnosed systemic lupus erythematosus: the real-world GULP prospective observational study[J]. *RMD Open*, 2022,8(2):e002701.
- [19] PENG L, WU C, HONG R, et al. Clinical efficacy and safety of sirolimus in systemic lupus erythematosus: a real-world study and meta-analysis[J]. *Ther Adv Musculoskelet Dis*, 2020,12:1759720X20953336.
- [20] FANOURIKIS A, KOSTOPOULOU M, ANDERSEN J, et al. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus: 2023 update[J]. *Ann Rheum Dis*, 2024,83(1):15-29.
- [21] ALSHAIKI F, OBAID E, ALMUALLIM A, et al. Outcomes of rituximab therapy in refractory lupus: A meta-analysis[J]. *Eur J Rheumatol*, 2018,5(2):118-126.
- [22] 张辉, 杨念生, 鲁静, 等. 狼疮肾炎诊疗规范[J]. *中华内科杂志*, 2021,60(9):784-790.
- ZHANG H, YANG N S, LU J, et al. Recommendations for the diagnosis and management of lupus nephritis in China [J]. *Chin J Intern Med*, 2021,60(9):784-790.
- [23] FURIE R A, ROVIN B H, GARG J P, et al. Efficacy and safety of obinutuzumab in active lupus nephritis[J]. *N Engl J Med*, 2025,392(15):1471-1483.
- [24] ARNOLD J, DASS S, TWIGG S, et al. Efficacy and safety of obinutuzumab in systemic lupus erythematosus patients with secondary non-response to rituximab[J]. *Rheumatology (Oxford)*, 2022,61(12):4905-4909.
- [25] CHEN Y, WANG L, LI N, et al. Tripterygium glycosides for safely controlling disease activity in systemic lupus erythematosus: a systematic review with meta-analysis and trial sequential analysis[J]. *Front Pharmacol*, 2023,14: 1207385.
- [26] WEENING J J, D'AGATI V D, SCHWARTZ M M, et al. The classification of glomerulonephritis in systemic lupus erythematosus revisited[J]. *Kidney Int*, 2004, 65(2): 521-530.
- [27] BAJEMA I M, WILHELMUS S, ALPERS C E, et al. Revision of the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society classification for lupus nephritis: clarification of definitions, and modified National Institutes of Health activity and chronicity indices[J]. *Kidney Int*, 2018, 93(4):789-796.
- [28] WU Q, ZHAO M X, HUANG X S, et al. The use of belimumab on patients with both systemic lupus erythematosus and immune thrombocytopenia: A retrospective cohort study[J]. *Lupus*, 2024,33(6):608-614.
- [29] BARBHAIYA M, ZUILY S, NADEN R, et al. The 2023 ACR/EULAR antiphospholipid syndrome classification criteria[J]. *Arthritis Rheumatol*, 2023,75(10):1687-1702.
- 收稿日期(Received): 2025-08-25
修订日期(Revised): 2025-11-01
接收日期(Accepted): 2025-11-11
出版上线(Published online): 2025-12-25
(本文编辑:张 宁)